KARLYON ENTERPRISE S.A.

(Soluções Académicas e Empresariais Aplicadas)

Entidade Formadora: ENCORP • Curso de CPD (Desenvolvimento Profissional Contínuo)

Sinais vitais e interpretação

Interpretar e alertar

Aula 5 de 5 · 1 hora

Coordenador: Sacaita Manuel Inácio

Formação não qualificante, de carácter habilitante

Interpretar e alertar

No final desta aula o formando deve ser capaz de:

Valores de referência, tendências, comunicação com SBAR e escalada de cuidados.

Os sinais vitais só ganham sentido quando interpretados em conjunto e comparados ao longo do tempo. Um valor isolado pode enganar; uma tendência conta uma história.

Nesta aula aprende a ler os sinais vitais em conjunto, a reconhecer o doente que se agrava e a comunicar com clareza usando o método SBAR.

Roteiro

1. O que vai aprender nesta aula
2. Ver o conjunto, não só o número
3. Sinais de alerta
4. NEWS2: como funciona
5. Comunicar com SBAR
6. Exemplo de SBAR
7. Registar bem
8. Quando e como escalar
9. Caso: homem em pós-operatório
10. Caso: resolução
11. Erros frequentes
12. Pontos-chave
13. Para reflectir
14. Para aprofundar

O que vai aprender nesta aula

No final desta aula será capaz de:

1. Interpretar os sinais vitais em conjunto e em tendência
2. Reconhecer os sinais de alerta de deterioração
3. Usar a escala NEWS2 como apoio
4. Comunicar com o método SBAR
5. Registar e escalar de acordo com o protocolo

Ver o conjunto, não só o número

- Compare sempre com os **valores anteriores** do próprio doente
- Valorize **mudanças** mais do que valores isolados
- Considere o contexto: idade, doenças, medicação, ansiedade, dor
- Confie no seu **julgamento clínico**: se o doente «parece mal», actue
- Meça a frequência respiratória e o estado de consciência: são os melhores sinais de agravamento

Sinais de alerta

Parâmetro	Sinal de alerta no adulto
Frequência respiratória	8 ou menos, ou 25 ou mais
SpO_2	91% ou menos
Pulso	40 ou menos, ou 131 ou mais
TA sistólica	90 mmHg ou menos
Temperatura	35,0 °C ou menos, ou 39,1 °C ou mais
Consciência	Qualquer alteração nova (confusão, sonolência)

Um doente pode ter **vários sinais ligeiros** que, juntos, indicam gravidade.

NEWS2: como funciona

A **NEWS2** (National Early Warning Score 2) atribui pontos a 7 parâmetros: FR, SpO_2, oxigénio suplementar, TA sistólica, pulso, consciência e temperatura.

- Soma baixa: vigilância de rotina
- **3 pontos num único parâmetro**: alerta urgente
- Soma média ou alta: resposta urgente ou emergência

A NEWS2 **apoia** a decisão; **não substitui** o julgamento clínico nem os protocolos da instituição.



Comunicar com SBAR

Letra	Conteúdo
S	**Situação:** quem é, onde está e qual é o problema
B	**Antecedentes** (*Background*): diagnóstico, doenças, medicação, alergias
A	**Avaliação:** sinais vitais, tendência, o que vê

Exemplo de SBAR

S: «Chamo da enfermaria 3, cama 12. O Sr. António, 70 anos, está com falta de ar de início súbito.»

B: «Internado por pneumonia, tem hipertensão e é alérgico à penicilina.»

A: «FR 28, SpO_2 88% em ar ambiente, pulso 120, TA 100/60, temperatura 38,6 °C. Está sonolento. Há 2 horas estava melhor.»

R: «Preciso que venha vê-lo agora. Começo oxigénio conforme o protocolo.»

Registar bem

- **Valor, unidade, hora e local** de cada medição
- Intervenções feitas e **resposta** do doente
- A quem comunicou, a que horas e o que foi decidido
- **Não registe** o que não mediu
- Registe a **tendência** (gráficos de sinais vitais ajudam a ver)
- Corrija erros sem rasurar

Quando e como escalar

- Siga o **protocolo** da instituição para chamar a equipa
- Comunique **cedo**: não espere o fim do turno
- Se a resposta for insuficiente, **escalone** para nível superior (chefia, equipa de emergência)
- Em **emergência** (paragem, via aérea comprometida, choque), peça ajuda e inicie a actuação imediata
- Reavalie depois de cada intervenção

Caso: homem em pós-operatório

Um homem de 60 anos, no 2.º dia após cirurgia, tem às 8h: FR 16, SpO_2 96%, pulso 84, TA 130/80. Às 12h: FR 22, SpO_2 93%, pulso 108, TA 108/68, temperatura 38,3 °C. Está mais sonolento.

> **Pense antes de avançar:** os valores estão «quase normais». O que faz?

Caso: resolução

1. Os valores individuais parecem aceitáveis, mas a **tendência** é de agravamento: FR e pulso a subir, TA e SpO_2 a descer, febre e sonolência nova
2. Pode tratar-se de **infecção/sépsis** ou complicação pós-operatória
3. Aplique a **NEWS2** e siga o protocolo de alerta
4. Comunique com **SBAR** ao médico, de imediato
5. Mantenha oxigénio conforme prescrição, posição adequada e vigilância apertada
6. Reavalie com frequência e registe tudo

Erros frequentes

- Valorizar só um número e ignorar o conjunto
- Medir, registar e **não comunicar** valores alterados
- Esperar pelo fim do turno para dizer
- Comunicar sem dados: «o doente está mal»
- Não reavaliar depois de actuar
- Confiar apenas no monitor e não olhar para o doente

Pontos-chave

1. Interprete em conjunto e em tendência
2. FR e consciência são sinais precoces
3. NEWS2 apoia o julgamento clínico
4. SBAR: Situação, Antecedentes, Avaliação, Recomendação
5. Registe valor, unidade, hora, local e acção
6. Comunique cedo e reavalie

Para reflectir

Discuta com um colega ou com o seu orientador:

? Qual foi a última vez que comunicou uma deterioração? Como o fez?

? Como pode melhorar a passagem de turno no seu serviço?

? Que obstáculos encontra para escalar cuidados e como os ultrapassar?

Para aprofundar

Consulte no ENCORP:

→ NEWS2: escala de alerta precoce

→ Sinais vitais: valores de referência

→ Avaliação primária ABCDE

PRÓXIMO PASSO

Teste de avaliação

- 10 perguntas de escolha múltipla
- Nota mínima de aprovação: 70%
- Reveja os pontos-chave antes de começar
- Pode repetir o teste as vezes que quiser